

18 DOSE DE ANTIMICROBIANOS, CORREÇÕES, DILUIÇÕES E TEMPO DE INFUSÃO EM ADULTOS

TABELA DE DOSE DE ANTIMICROBIANOS, CORREÇÕES PARA FUNÇÃO RENAL, DILUIÇÕES E TEMPO DE INFUSÃO. BASE: BRCAST (Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade Antimicrobiana)

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para ClCreat, usar CKD- EPI ou MDRD.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E ClCr>50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES
		ClCr 50 – 10ml/min	ClCr < 10ml/min	
Amicacina Utilizar Peso Ajustado se IMC>30	ClCr > 80 ml/min: 15 a 30 mg/kg/dia IV q24h (>15mg/kg se paciente crítico e com dosagem sérica) Se IM, máx 1g (4mL)	7,5 mg/Kg/d* q** 24h	7,5 mg/Kg/d IV q48h + Hemodiálise: fazer 50% (3,75 mg/kg) da dose após diálise Se coincidir: fazer dose q48h pré diálise e pós diálise (dose-dependente)	SF / SG5% / RL - Infusão: 30-60min – 5mg/mL Se restrição de volume: máx 10mg/mL Alvo nível sérico vale: < 1ug/mL; pico: 56-64 ug/mL Evitar co-administração com: anfotericinas, ciclosporina, piperacilina+tazobactam (e outras penicilinas) e vancomicina.
Ampicilina (2g) + Sulbactam (1g) Prescrever em dose composta 3g = 1 fr	3g IV q6 - 8h <i>PAV Acineto MDR: 9g IV q 8h, infusão em 3h</i>	3g IV q8 – 12h	3g IV q24h Hemodiálise: 3g IV q24h, fazer dose após diálise	SF (preferencial) / SG5% - Infusão: 30min a 3h. Confirmar estabilidade do produto disponível. Se restrição de volume: máx 250mg/mL Monitorar função hepática.
Ampicilina	200 mg/kg/dia IV q4-6h (2g IV 4-8h)	1-2g IV q6-8h	1-2g IV q12h. Hemodiálise: Fazer uma das doses após diálise	SF / SG5% / RL: 1g/50mL; 2g/100mL. Se restrição de volume: máx 30mg/mL. Infusão: 15-30min.
Amoxicilina (1g) + Clavulanato (200mg) Cálculo da dose por amoxicilina Prescrição em dose composta 1,2g = 1 fr	1000mg+200mg IV q8h <i>Peso < 40 Kg: 25+5mg/kg q8h</i>	Ataque: 1000mg+200mg IV Manut: 500 mg+100 mg IV q12h <i>Peso <40 Kg: 25+5mg/Kg q12h</i>	Ataque: 1000mg + 200mg IV Manut: 500mg+100mg IV q24h <i>Peso < 40 Kg: 25+5 mg / Kg q24h</i> Hemodiálise: Ataque: 1000mg+200mg Manut: 500mg+100mg IV q24h. Fazer dose extra após diálise	SF (1,2g/100mL; 600mg/50mL). Não administrar IM. Infusão: Direto (3 – 5min) ou em 30 min. Incompatível com amiodarona.
Azitromicina	500mg IV/VO q24h	500mg IV/VO q24h	500mg IV/VO q24h	SF / SG5% – Infusão: 1mg/mL em 3h (preferencial) ou 2mg/mL em 1h. Infusões rápidas aumentam potenciais reações adversas. Incompatível com ceftriaxona. Muitas interações - monitorar função cardíaca (intervalo QT) e hepática.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E CICr>50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		CICr 50 – 10ml/min	CICr < 10ml/min	
Aztreonam	1-2g IV q6-8h <i>P. aeruginosa: 2g IV q6h</i>	1-1,5g IV q8h	1-2g IV q24h + Hemodiálise: fazer dose após diálise	SF / SG5% (>50mL). Se restrição de volume: 20mg/mL. Infusão: 20 – 60min ou direto (3 – 5min) Monitorar função hepática e renal.
Cefalotina	1-2g IV q6h	6 – 8h	12h	SF / SG5% / RL (50 – 100mL) Infusão: 3 – 30min. (doses de 2g: 30min)
Cefazolina	1-2g IV q8h. <u>Se IMC> 30: 2g IV q 8h,</u> <u>Se >120 kg, 3g IV q8h</u> <u>Máx: 12g/d</u> <u>Profilaxia cc: 1 h antes da</u> <u>incisão (ou indução</u> <u>anestesia)</u>	1-2g IV q12h	1-2g IV q24h + Hemodiálise: 500mg a 1g após diálise	SF / SG5% (50 – 100mL) – Infusão: 30 – 60min ou direto (3 – 5min) Se uso profilático no CC e cirurgia prolongada, repetir após 3h do início
Cefotaxima	1-2g IV q4-8h	2g IV q12–24h	2g IV q 24h + Hemodiálise: 1g após diálise	SF / SG5% / SG10% / RL (50 – 100mL em 30min) – 10 a 40mg/mL ou direto (3-5min) Pode ser feito IM.
Ceftazidima	1-2g IV q8h Ou 1g q6h	2g IV q12 – 24h	2g IV q 24-48h; + Hemodiálise: 1g após diálise	SF / SG5% / SG10% / RL (10-50mL) – 1g/50mL; 2g/100mL. Se restrição de volume: 40mg/mL Infusão: 15-30min. Monitorar INR e função renal.
Ceftazidima (2g) + Avibactam (0,5g) (ITU complicada, Abdomen, Pneumonia/PAV) Prescrever em dose composta 2,5g = 1 fr NDM Pan-R: Ceftazidima/avibactam + aztreonam, administrados concomitantemente em 3h	2,5g IV q8h Infusão em 2 horas. Se IRA, fazer dose plena de ataque por 24h	CICr 30-50mL/min: 1,25g IV q8h * CICr 16-30 mL/min: 0,94g IV q12h * *Preparada pelo setor de Dose Unitária - Farmácia HU : 1,25g/50mL e 0,94g/50mL de SF	CICr 6-15mL/min: 0,94g IV q24h* CICr ≤ 5mL/min: 0,94g IV q48h* (fazer dose após diálise) * Preparada pelo setor de Dose Unitária - Farmácia HU: 0,94g/50mL SF	SF / SG5% / RL (50 – 250mL). Infusão: mínimo 2h. Associado à furosemda, aminoglicosídeos, ou vancomicina aumenta sua toxicidade. Varfarina aumenta risco de sangramento. Acesso preferencialmente exclusivo. Monitorar função renal. NDM Pan-Resistente: prescrever ceftazidima-avibactam e aztreonam, ambos infusão em 3 h e correr ao mesmo tempo. Utilizar SF 100mL para cada 1.

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para ClCreat, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
Peso Ajustado = $\text{Peso Ideal} + 0,4 \times (\text{Peso Real} - \text{Peso Ideal})$ CCIH + FARMÁCIA-HU/UEL.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E CClr>50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		CClcr 50 – 10ml/min	CClcr < 10ml/min	
Ceftolozana (1g) + Tazobactam (0,5g) (ITU grave, Abd, PAV) Prescrever em dose composta 1,5g = 1 fr	1,5g IV q8h (ITU, Abdome) 3g IV q8h (Pneumonia)	CClcr 30-50mL/min: 750mg q 8h CClcr 15-29mL/min: 375mg q 8h Pneumonia: dobrar a dose *Preparada pelo setor de Dose Unitária - Farmácia HU: 750mg/50mL e 375mg/50mL SF	CClcr <15mL/min: 750mg ataque, 150 mg q 8h (fazer dose após diálise). Pneu: 2,25g ataque, 450mg q8h *Preparada pelo setor de Dose Unitária - Farmácia HU: 750mg/50mL, 450mg/50mL e 150mg/50mL SF	SF / SG5% (100mL) - Infusão: 60min – 3h Exclusivamente IV 1,5g/100mL; 3g/200mL Monitorar função renal.
Ceftriaxona	2g IV q24h <i>Meningite:</i> 4g IV q24h OU 2g IV q12h	1-2g IV q24h	1-2g IV q24h	SF/SG5% (50–100mL). Infusão: 30min ou IV direto: 3-5min. Se restrição de volume, máx 50mg/mL. Contraindicado com cálcio IV e RL. IV ou IM (com lidocaína1%). Incompatível com azitromicina e outros medicamentos. Monitorar INR.
Cefepime	1-2g IV q8-12h <i>Neutropenia e/ou IMC>30:</i> 2g IV q8h	Cl 30-60: 2g IV q12h Cl 11-29: 2g IV q24h	Cl < 11: 1g IV q24h. + Hemodiálise: 1g após diálise	SF / SG5% / RL – Infusão: 30min - 3h ou direto (3 a 5 min). Se restrição de volume, máx 40mg/mL Monitorar função renal e INR. Observar SNC principalmente em renais
Ceftarolina (pele/PAC)	600mg IV q8h – PAC 600mg IV q12h – pele	Cl 30-50: 400 mg q 12h Cl 15-30: 300 mg q 12h	Cl < 15: 200mg IV q12h Hemodiálise: 200mg IV q12h	SF / SG5% / RL (50 – 250mL) - Infusão: 5 – 120min. Se restrição de volume: máx 12mg/mL. Associação com varfarina aumenta o risco de sangramento.
Ciprofloxacino	200- 400mg IV q12h 500mg VO q12h <i>P. aeruginosa:</i> 400mg IV q8h 750mg VO 12/12h	Cl 30-50: 200- 400 mg iv q 8-12h Cl 5-29: 200-400 mg q 18-24h	Cl 5-29: 200- 400mg IV q24h. Hemodiálise: Fazer a dose após diálise	Infusão: 200mg/h em adultos; 100mg/h em crianças – Bolsa pronta para uso. Acesso venoso de grande calibre reduz reações infusionais. VO: preferencialmente <u>em jejum</u> e longe de itens com cálcio, magnésio e zinco.
Claritromicina	250- 500mg IV/VO q12h	500mg IV/VO q12-24h	500mg IV/VO q12-24h Hemodiálise: Fazer dose após a diálise	SF / SG5% / RL (500mg/250mL) Exclusivo EV. Não administrar IM. Infusão: 60min (não fazer bolus). Monitorar função renal, hepática e cardíaca. Muitas interações consolidadas: monitorar.

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para CClcreat, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
Peso Ajustado = $\text{Peso Ideal} + 0,4 \times (\text{Peso Real} - \text{Peso Ideal})$ CClH + FARMÁCIA-HU/UEL.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E CICr>50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		CICr 50 – 10ml/min	CICr < 10ml/min	
Clindamicina	900mg IV q8h 600mg IV q6h 300mg VO q6-12h <i>Sd Choque Tóxico - Fasceíte Necrotizante: 900mg IV q6h</i>	900mg IV q8h	900mg IV q8h	SF / SG5% (50 – 100mL) – Infusão: 30min Não exceder 18mg/mL e 30mg/min Monitorar função hepática e renal. Incompatível com ceftriaxona e outros medicamentos.
Daptomicina (ICS e pele e partes moles) Utilizar Peso Ajustado se IMC>30	4-8mg/kg/dia IV q24h Bacteremia/Endocardite: 8-12mg/Kg/dia IV q24h	CI > 30: 4-6mg/kg IV q24h	CI < 30: 6mg/kg IV q48h	SF / RL (incompatível com SG) IV direto (2min) ou 50mL em 30min. Pacientes de 0 a 6 anos: infusão em 60min. Monitorar CPK basal e cada 5 dias. Contraindicado com estatinas (suspender temporariamente). Muitas incompatibilidades.
Ertapenem	1g IV q24h	CI > 30: 1g IV q24h	CI < 30: 500mg IV q24h. + Hemodiálise: Fazer 150mg após diálise se dose 6h antes da HD	SF 50-100mL. Infusão: 30min. Associação com ácido valpróico reduz efeito anticonvulsivante (interação consolidada). Incompatível com SG. Monitorar função renal, hepática e hematopoiese.
Gentamicina Utilizar Peso Ajustado se IMC>30	CI > 80 ml/min: 6-7mg/Kg/dia IV q24h Infecções graves: 7mg/kg/dia	CI 60-80: 4 mg/Kg/dia q 24h CI 40-60: 3,5mg/Kg/dia q 24h CI 30-40: 2,5mg/Kg/dia q 24h	CI 20-30: 4mg/Kg/dia q 48h CI 10-20: 3mg/Kg/dia q 48h CI 0-10: 2mg/Kg/dia q 72h Hemodiálise: Fazer + 50% (1mg/kg/dose) após diálise	SF/SG5% /RL. Infusão: 30–60min. Se restrição de volume: diluir em 50-100mL Monitorar oto e nefrotoxicidade. Associação com furosemida e/ou vancomicina aumenta toxicidade
Imipenem Prescrever em dose composta 500mg = 1 fr	500mg IV q6h OU 1g IV q8h <i>P.aeruginosa ou MO com sensibilidade intermediária: 1g q 6h</i>	CI 30-60: 300mg IV q6h ou 500mg IV q8h 500mg IV q6h (MO sensibil. Interm.) CI 15-30: 500mg IV q12h (idem MO sensibil. Interm.)	CI <15: 200mg q6h ou 500mg q 12h (1 dose após a diálise). Evitar uso em pacientes com CI<15, exceto se HD há 48h	Preferencialmente em SF (500mg/100mL) Infusão: 40min - 3h – Se restrição de volume: máx 8mg/mL Associação com ácido valpróico reduz efeito anticonvulsivante (interação consolidada).
Levofloxacino	500-750mg VO/IV q24h Max: 500mg q12h	CI 20-49: 750mg IV q48h	CI <20 ou hemodiálise: Ataque: 750mg IV Manut: 500mg IV q48h	Infusão: 750mg em 90min, 500mg em 60min - Bolsa pronta para uso Contraindicado com amiodarona (rever terapêutica) VO: preferencialmente <u>em jejum</u> e longe de itens com cálcio, magnésio e zinco.

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para CICreat, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
Peso Ajustado = $\text{Peso Ideal} + 0,4 \times (\text{Peso Real} - \text{Peso Ideal})$ CCIH + FARMÁCIA-HU/UEL.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E C _{ICr} >50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		C _{ICr} 50 – 10ml/min	C _{ICr} < 10ml/min	
Linezolida (pele / PNM)	600mg VO/IV q12h	600mg IV/VO q12h	600mg q 12h. Fazer uma das doses após diálise	Infusão: 30min a 2h - Bolsa pronta p/ uso Interações medicamentosas graves bem documentadas: monitorar associações.
Meropenem	1-2g IV q8h <i>P. aeruginosa</i> e Meningite: 2g IV q8h	CI 50–25mL/min: 1g IV q12h (<i>P. aeruginosa</i> ou meningite: 2g q12h) CI 25 – 10mL/min: 500mg IV q12h (<i>P. aeruginosa</i> ou meningite: 1g q 12h)	CI <10: 500mg IV q 24h (<i>P. aeruginosa</i> ou meningite: 1g q24h) Hemodiálise: Fazer 500 mg após diálise	SF (preferencial) Infusão: 3h. SG5% - infundir em até 30min. Infusão rápida: 15 a 30 min. Se restrição de volume máx 20mg/mL . Associação com ácido valpróico, reduz efeito anticonvulsivante (interação consolidada) Incompatível com Midazolam - verificar acessos venosos disponíveis.
Metronidazol	30mg/Kg/dia IV/VO q6-8h Peritonite estercorácea: ataque de 15mg/kg C. difficile (leve/mod): 500mg VO q8h	30mg/Kg/dia IV q6h	CI <10: 15mg/Kg/dia q 12h Hemodiálise: Fazer uma das doses após diálise	Infusão: 30 – 60min - Bolsa pronta para uso VO: preferencialmente com alimento para redução de epigastria.
Moxifloxacina	400mg IV/VO q24h	400mg IV/VO q24h	400mg IV/VO q24h	Infusão: 60min - Bolsa pronta para uso VO: preferencialmente <u>em jejum</u> e longe de itens com cálcio, magnésio e zinco.
Oxacilina	1-2g IV q4-6h	2g IV q4h	2g IV q4h Observar função hepática com dose > 12g/dia	EV ou IM - EV: SF (10-100mg/mL) / SG5% (10 - 30mg/mL) - Infusão: 60 min (não exceder 500mg/10min). Preferencialmente acesso exclusivo. Monitorar função hepática se tratamento > 14 dias.
Penicilina G	0,5-4 milhões UI q4h	0,5-4 milhões UI q8h	0,5-4 milhões UI q12h (inclui em hemodiálise, dar uma das doses pós diálise)	EV (50.000 a 145.000 UI/mL) / SF Infusão em 15 a 30 min em acesso periférico. Ped: máximo 100.000 UI/mL e Neo: 25.000UI/mL. Monitorar reações alérgicas.
Piperacilina-Tazobactam Prescrever em dose composta 4,5g = 1 fr	4,5g IV q6-8h	CI 20-40: 2,25g IV q6h <i>P. aeruginosa</i> : 3,375g IV q6h	CI <20: 2,25g IV q8h <i>P. aeruginosa</i> : 2,25g q6h + Hemodiálise: Fazer + 0,75g após diálise	SF (preferencial) / SG5% (50 – 150mL) Infusão: 30 min - 3h. Atenção: 4,5g = 11,2mEq de Na+ Associação com aminoglicosídeos deve ter horários distantes. Incompatível em Y-site com IR em BIC - usar acessos distintos. Associação com vancomicina aumenta risco de nefrotoxicidade.

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para C_{ICreat}, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
Peso Ajustado = Peso Ideal + 0,4 x (Peso Real – Peso Ideal) CCIH + FARMÁCIA-HU/UEL.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E C _{ICr} >50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		C _{ICr} 50 – 10ml/min	C _{ICr} < 10ml/min	
Polimixina B Usar peso atual Não usar para inalação Dose máxima por administração: 2.500.00UI Não usar em ITU	Ataque: 25.000 UI/kg IV ou 2,5 mg/kg, infusão em 2h em SG5% Manut: 15.000-25.000UI/Kg/dia IV q12h 2,5mg/kg/dia IV q12h 1mg=10.000UI 1 frasco = 500.000UI	15.000 a 25.000UI/Kg/dia IV q12h 2,5mg/kg/dia IV q12h infundir em 1-2h	15.000 a 25.000UI/Kg/dia IV q12h 2,5mg/kg/dia IV q12h infundir em 1-2h	EV: SG5%; Se Intratecal: reconstituir e diluir em SF 0,9% (CCIH) Infusão: Doses até 1MUI: infundir em 1h, >1MUI: em 90 - 120min Diluição PADRÃO: 500.000UI em 300-500mL Se restrição de volume, máx 3.000UI/mL Incompatível em Y-site com IR em BIC - usar acessos distintos. Evitar uso com curare: potencializa bloqueio neuromuscular Monitorar nefro e neurotoxicidade e parâmetros respiratórios. Solicitar acompanhamento do infectologista.
Polimixina E ou Colistina /Colistimetato (Peso atual X Peso ideal: usar o que for menor) - Preferência para ITU e inalatória	Ataque: 4 mg/kg de colistina base (CBA) (1mg CBA=30.000UI) C _{ICr} > 80mL/min: 5 mg/kg/dia, dividido em 2 a 4 vezes/dia. Não ultrapassar 360 mg CBA por dia	C _{ICr} entre 40-70mL/min : 2,5 a 3,8 mg/kg/dia q12 C _{ICr} entre 25-40mL/min: 2,5 mg/kg/dia q12-24	C _{ICr} entre 10-20mL/min: 1,5mg/kg/dia a cada 36 horas Hemodiálise intermitente: Dia sem diálise: 65mg de 12/12h Dia com diálise: fazer 50 mg após diálise Hemodiálise contínua: consultar CCIH	SF / SG5% (150mg/50mL) Infusão: 30 – 60min Colistina inalatória: 75 mg CBA em 4mL de solução salina, 2 a 3 x/dia em nebulizador apropriado (vibratório); reconstituído com AD. Box fechado. Consultar CCIH Monitorar nefro e neurotoxicidade e parâmetros respiratórios. Solicitar acompanhamento do infectologista
Sulfametoxazol-Trimetoprim Prescrever em dose composta 480mg = 1 amp Utilizar Peso Ajustado se IMC>30	5-20mg/kg/dia de trimetoprim IV/VO q6-12h	Idem. C _{ICr} entre 10-29: 5-10mg/kg/dia q 12h	Não recomendado Mas s/n: 5-10mg/kg/dia q24h Hemodiálise: Não recomendado Mas s/n: 5-10mg/kg q24h	SF / SG5% / RL (480mg/125mL). Se restrição de volume máx. 480mg/75mL de SG5%. Infusão: 30 - 90min. Muitas incompatibilidades relevantes: acesso exclusivo Incompatível em Y-site com IR em BIC - usar acessos distintos. Muitas interações consolidadas: monitorar.

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para C_{ICreat}, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
Peso Ajustado = $\text{Peso Ideal} + 0,4 \times (\text{Peso Real} - \text{Peso Ideal})$ CCIH + FARMÁCIA-HU/UEL.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E C _{ICr} >50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		C _{ICr} 50 – 10ml/min	C _{ICr} < 10ml/min	
Teicoplanina (utilizar peso atual)	Ataque: 12mg/kg/dia IV q12h (3 doses). Infecções graves: 12mg/Kg/dose IV 12h (3-5 doses). Manutenção: 6mg/kg/dia IV q24h. Graves: 12mg/kg/dia	CI 30-80: 6 mg/kg/dia q 48h Graves (Osso/articular/endocardite): 12mg/Kg q48h	CI <30: 6 mg/kg/dia q 72h. Graves: 12 mg/Kg q 72h Hemodiálise: Fazer a dose do dia após diálise	EV ou IM SF / SG5% / RL (20-100mL) Infusão: 30min ou direto (3 – 5 min) Monitorar nefrotoxicidade
Tigeciclina	Ataque: 100mg IV Manutenção: 50mg IV q12h <i>Child C</i> : 25 mg q12h. <i>CR ou PR (Sangue/Pulmão)</i> : Ataque: 200mg IV Manut: 100 mg q 12h	Ataque: 100mg IV Manutenção: 50mg IV q12h	Ataque: 100mg IV Manutenção: 50mg IV q12h	SF / SG5% - 100mL Se restrição de volume: máx 1mg/mL Infusão: 30 – 60min Monitorar função hepática e fatores de coagulação Efeito adverso mais comum: náuseas, vômitos
Tobramicina	6mg/kg/dia IV q24h Pacientes críticos: 7mg/kg/d IV q24h Inalatória: 300mg q12h 28d	1,7-2mg/kg/dia IV q24h	1,7-2mg/kg/dia IV q24h	SF / SG5% (50 – 100mL) Infusão: 30 – 60min Muitas interações consolidadas: monitorar. Associação com furosemda aumenta toxicidade

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para C_{ICreat}, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
 Peso Ajustado = $\text{Peso Ideal} + 0,4 \times (\text{Peso Real} - \text{Peso Ideal})$ CCIH + FARMÁCIA-HU/UEL.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E C _{ICr} >50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		C _{ICr} 50 – 10ml/min	C _{ICr} < 10ml/min	
Vancomicina (se MIC<2) (utilizar peso atual) Dose máxima por administração: 2g	Ataque: 25 a 30mg/kg IV Manutenção: 15-30mg/kg/dose IV q8-12h. Dose Máxima: 6g/dia (infundir em 2h). Vancocinemia no vale 4ª dose entre 15-20ug/mL	C _{ICr} 20-49mL/min: 15-20 mg/kg/dose IV q24h <i>Ajuste com vancocinemia no vale da 4ª dose</i>	C _{ICr} <20mL/min: 15-20mg/Kg q48h HD em 1 dia: 15mg/Kg HD em 2 dias: 25mg/Kg HD em 3 dias: 35mg/Kg Vancocinemia imediatamente antes da diálise	SF / SG5% (5mg/mL) Se restrição de volume, máx. 10mg/mL Infusão: máximo 20mg/min Infusões mais rápidas aumentam risco de reações adversas graves. Muitas interações consolidadas: monitorar Vanco oral (<i>Clostridioides difficile</i>) : 125 a 500mg q6h

ANTIFÚNGICOS

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E C _{ICr} >50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		C _{ICr} 50 – 10ml/min	C _{ICr} < 10ml/min	
Anfotericina B	0,5 a 1,5 mg/kg/dia iv q 24h	100% q 24h	100% q 24	Diluição exclusiva com SG5% Infusão: 2-6h. Se restrição de volume: máx. Periférico: 0,1mg/mL e Central: 0,25 –0,5mg/mL. Muitas incompatibilidades relevantes: acesso exclusivo.
Anfotericina lipossomal	3 a 5mg/kg/dia iv q 24h	100% q 24h	100% q 24	Diluição <u>exclusiva</u> com SG5%. Infusão: 1-2h. Se restrição de volume: máx 2mg/mL. Muitas incompatibilidades relevantes: acesso exclusivo
Anfotericina complexo lipídico	5mg/kg/dia iv q 24h	100% q 24h	100% q 24	Diluição exclusiva em SG5%. Infusão: 1-2h Se restrição de volume: máx 2mg/mL Muitas incompatibilidades relevantes: acesso exclusivo
Anidulafungina	200mg ataque, depois 100mg iv q24h	100% q 24h	100% q 24h	SF / SG5% - Infusão: não exceder 1,1mg/min Se restrição de volume: máx. 0,77mg/mL
Caspofungina	70mg ataque 50mg iv q 24h	100% q 24h	100% q 24h	SF / RL– Infusão em 1h. Se restrição de volume: máx 0,5mg/mL. Se insuf. hepática: 70mg (ataque), 35mg q 24h. No uso simultâneo com rifampicina, efavirenz, nevirapina, fenitoína ou carbamazepina, pode-se considerar uma dose diária de 70mg (interação consolidada).
Fluconazol	100 a 400mg iv q 24h Candidemia: 12 mg/kg ataque, manter 400mg/dia	50% q 24h	50% da dose, q24h Se hemodiálise, dose plena. Fazer a dose após diálise. q 24h	Infusão: 200mg/h - Bolsa pronta para uso

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para C_{ICr} Creat, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
Peso Ajustado = Peso Ideal + 0,4 x (Peso Real – Peso Ideal) CCIH + FARMÁCIA-HU/UEL.

DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E CICr>50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		CICr 50 – 10ml/min	CICr < 10ml/min	
Micafungina	100mg iv q 24h	100% q 24h	100% q 24h	SF / SG5% (100mL, máx 2mg/mL) Infusão: 1h Incompatível em Y-site com IR em BIC - usar acessos distintos. Contém 200mg de lactose.
Voriconazol Usar peso Ideal	6mg/kg q 12h, seguido de 4mg/kg q 12h iv/vo	Cl < 50 : não usar iv, só vo 400 mg q12h (2 doses) Manter 200mg q 12h	Só vo 400 mg q12h (2 doses) Manter 200mg q 12h	EV: SF / SG5% (0,5mg/mL – 5mg/mL) Infusão: 1 – 2h (máx 3mg/kg/h). Muitas interações medicamentosas consolidadas. Se uso de fenitoína concomitante, sugere-se dose de 5mg/kg. VO: <u>melhor absorvido sem alimento</u> – pausar dieta 1h antes e após cada dose
DROGA	DOSE PARA TRATAMENTO EMPÍRICO E CICr>50	AJUSTE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL POR CLEARANCE (ml/min)		DILUIÇÕES, TEMPO INFUSÃO e OBSERVAÇÕES.
		CICr 50 – 10ml/min	CICr < 10ml/min	
ANTIVIRAIS				
Aciclovir Utilizar Peso Ajustado se IMC>30	SNC: 5-12,5mg/Kg iv q8h	Cl 10-50: 5-12,5mg/Kg iv q12-24h	Cl <10: 2,5-6,25mg/Kg iv q24h Hemodiálise: fazer a dose após diálise	SF / SG5% (1-5mg/mL). Se restrição de volume: 7mg/mL. Infusão: 60min (não fazer bolus). Exclusivamente EV (não administrar IM). Acesso exclusivo.
Ganciclovir	Indução: 5mg/Kg iv q12h por 14 dias Manutenção: 5mg/Kg iv q24h ou 6mg/Kg q24h 5x/sem	Cl 10-50: 2,5mg/Kg q 24h	Cl <10: 1,25mg/Kg 3x/sem Hemodiálise: fazer uma dose pós diálise	SF (5mg/mL) - Infusão em 60min. Exclusivamente EV. Medicamento preparado em todas as doses pelo setor de Dose Unitária - Farmácia HU.

*d= dia; ** q= intervalo DOSE DE ATAQUE: 1ª dose sempre plena. Manter sem correção nas 1ªs 24 horas. Para ClCreat, usar CKD- EPI ou MDRD. Peso Ideal: Fórmula de Robinson.
 Peso Ajustado = $\text{Peso Ideal} + 0,4 \times (\text{Peso Real} - \text{Peso Ideal})$ CCIH + FARMÁCIA-HU/UEL.